

坐骨神経痛の診断と治療

— なぜ初診でMRIを急がないのか？ —

保存療法と手術の真実をエビデンスで読み解く。

医療従事者向け | 2026年9月28日確認

保存療法の継続と、赤旗トリアージ。

激しい下肢痛で来院した患者に、
直ちにMRIを撮るべきでしょうか？

診療の原則

赤旗徴候がなければルーチン画像は不要。

8～9割は保存療法で自然軽快します。

4つの視点からエビデンスを整理します。

1

病態と赤旗トリアージ

化学的神経根炎と緊急手術の適応。

2

画像検査の適正タイミング

なぜ初診時MRIを推奨しないのか。

3

治療のエビデンスと選択

保存療法の真実と手術療法の長期予後。

見逃してはならない4つの危険サイン。

- **排尿・排便障害**

尿閉・失禁・会陰部麻痺。

- **進行性の運動麻痺**

下垂足や急激な脱力悪化。

- **がん・感染症示唆**

癌既往・体重減少・発熱。

- **48時間以内減圧**

馬尾症候群は緊急手術適応。

赤旗を認めたら直ちに緊急MRI・脊椎外科紹介。

感度と特異度を分けて評価する。

通常のSLR(患側挙上)

感度 90%
除外診断に有用。



交叉SLR(健側挙上)

特異度 90%超
陽性確定の強力な根拠。
ヘルニアの決定打。

放散痛の再現を確認して判定します。

激痛＝即時MRI撮影ではない。

よくある誤解

痛みが強いなら、
初診時にすぐMRIを
撮るべきである。

エビデンスの真実

健常者でも高頻度に異常。
早期MRIは予後を改善せず、
過剰医療を招きます。

赤旗のない急性期はルーチン画像を推奨しません。

4疾患の特徴と鑑別の決め手。

疾患	症状	鑑別点
脊柱管狭窄	立位歩行で増悪	前屈で著明に軽快
梨状筋症候群	臀部深部の痛み	坐骨切痕の圧痛
仙腸関節障害	臀部・鼠径部痛	Patrickテスト陽性
閉塞性動脈硬化	血管性間欠跛行	休息で軽快・ABI低下

骨盤・股関節・血管性疾患を除外します。

推奨と非推奨を分ける。

エビデンスに基づく基本方針。

推奨

活動維持とNSAIDs短期間。

非推奨

ベッド安静・プレガバリンの漫然投与。

PRECISE試験：プレガバリンは偽薬と差なし。

1年後の主観的回復率。

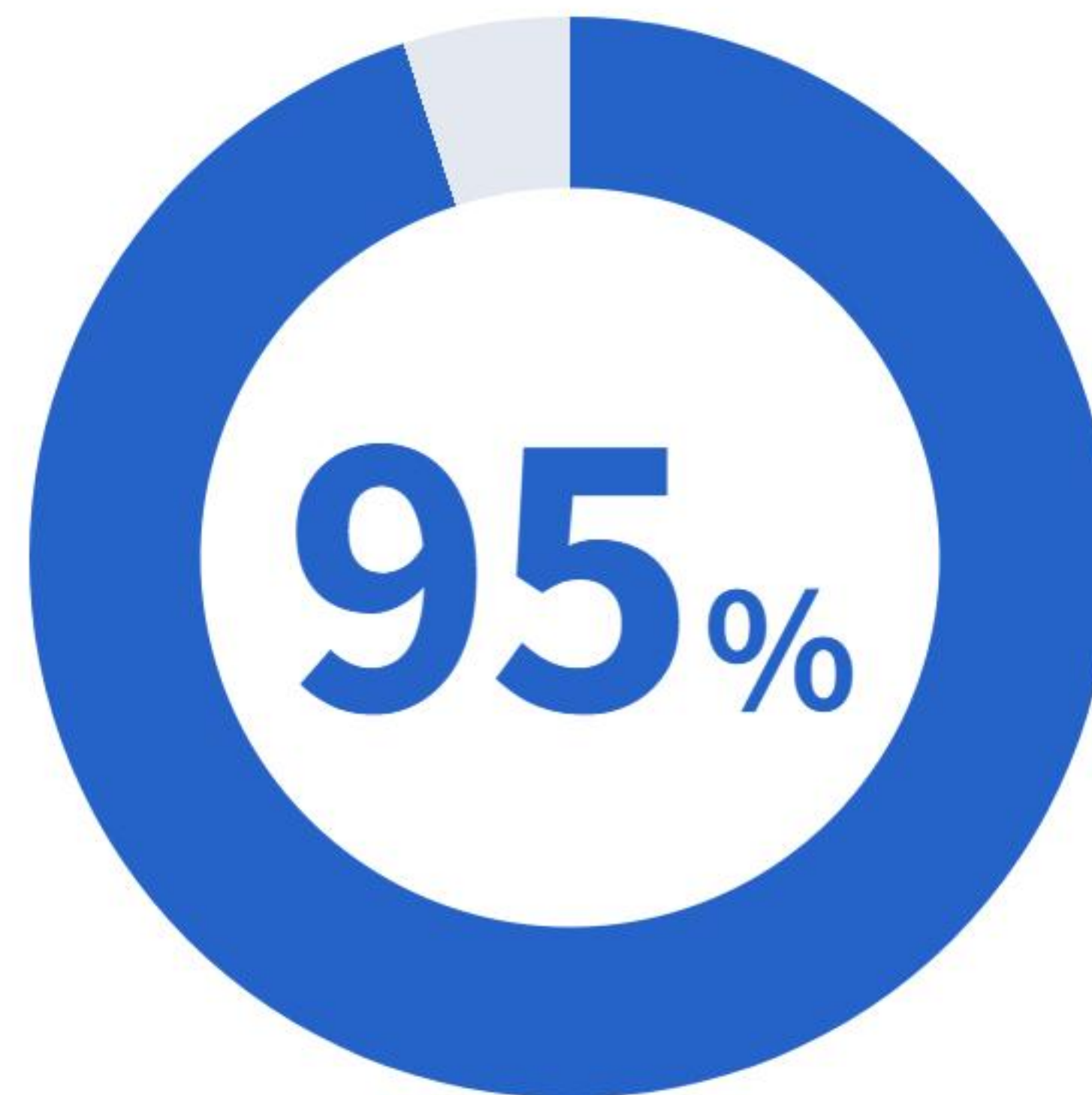
NEJM 2007

回復率

早期手術 95% = 待機保存
95%

追跡期間 1年間 (283例)

早期手術の利点は早期除痛。



時期に応じた3ステップ。



赤旗がなければ初期は保存継続。

坐骨神経痛診療の3大原則。

原則1

赤旗トリアージ
馬尾症候群・下垂
足は緊急手術。

原則2

初診MRIは急がない
赤旗なければ6～12
週は保存療法。

原則3

手術の真価は早期除痛
1年後の回復率は保存
と同等（95%）。

大半は自然治癒することを説明し、不安を和らげます。

臨床における留意事項

**この動画は一般的な情報提供であり、
診断・治療の代わりにはなりません。
症状がある場合は医療機関を受診してください。**

本動画は医療従事者向けの医学教育・情報提供を目的としています。

ご視聴ありがとうございました。

チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。

本日の要点

手術と保存療法の
回復率は同等。

参考文献

詳しい文献は、
概要欄の記事へ。

次回予告

最新エビデンスを
お届けします。

※治療方針は主治医とご相談ください。